OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 32

Tema 32: Desarrollo del apego. La formación del vínculo afectivo. Problemas específicos de una inadecuada configuración del apego. Modelos educativos parentales y consecuencias en los menores. La parentalidad positiva

Ámbito: Psicología del Desarrollo, Dinámicas Familiares, Buen Trato y Acción Socioeducativa Municipal

Tema 32 — Desarrollo del apego. La formación del vínculo afectivo. Problemas específicos de una inadecuada configuración del apego. Modelos educativos parentales y consecuencias en los menores. La parentalidad positiva

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Psicología del Desarrollo, Dinámicas Familiares y Acción Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El apego y los vínculos afectivos tempranos constituyen la piedra angular del desarrollo psicológico, emocional y social del ser humano. La necesidad primordial de vinculación afectiva hacia una figura protectora y sensible no es una consecuencia secundaria de la alimentación o la satisfacción de necesidades biológicas básicas, sino un imperativo primario, filogenéticamente arraigado en la especie humana, cuya función primordial es asegurar la supervivencia física y la regulación emocional del individuo inmaduro. De la calidad de este lazo afectivo primario emergen los cimientos de la confianza básica, la autoestima, la empatía, la autorregulación emocional y los esquemas mentales que guiarán las futuras relaciones interpersonales a lo largo de todo el ciclo vital.

En el marco competencial de los **Servicios Sociales Municipales** (atribuidos por los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL**, y desarrollados por la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía - LSSA**), el Educador y la Educadora Social desempeñan un papel técnico prioritario en la protección de la infancia y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. La intervención socioeducativa municipal con menores en riesgo no puede desligarse del análisis pormenorizado de las pautas de apego y de los estilos educativos desplegados por las figuras parentales en el hábitat doméstico.

Asimismo, el marco tuitivo estatal configurado por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** y el ordenamiento autonómico establecido por la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, imponen a las Administraciones Locales la obligación inexcusable de promover la **parentalidad positiva**, erradicando de raíz cualquier forma de violencia, castigo corporal, humillación o negligencia afectiva como método de disciplina o crianza. La adecuada capacitación técnica del Educador/a Social para evaluar las pautas de vinculación, detectar desórdenes graves del apego, corregir modelos educativos disfuncionales y promover la parentalidad positiva en el término municipal de Utrera resulta determinante para salvaguardar el interés superior del menor y evitar la adopción de medidas traumáticas de separación familiar.

```
                ARQUITECTURA DEL VÍNCULO AFECTIVO TEMPRANO
+-------------------------------------------------------------------------+
| BASE BIOLÓGICA/ETOLÓGICA   | Lorenz (Impronta) y Harlow (Confort contacto)|
| TEORÍA DEL APEGO           | Bowlby (Sistema conductual, Base segura)   |
| TIPOLOGÍAS Y MODELOS       | Ainsworth (Situación Extraña) y Main (Tipo D)|
| DINÁMICA FAMILIAR          | Baumrind / Maccoby-Martin (Estilos parent.)|
| PARADIGMA PÚBLICO          | Parentalidad Positiva (Rec 2006/19, LOPIVI)|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

---

2. Desarrollo del Apego: Fundamentos Teóricos y Concepto

2.1. Raíces Etológicas y Experimentales: Lorenz y Harlow

Para comprender la formulación contemporánea del apego, es preceptivo analizar la ruptura epistemológica que desbancó tanto al psicoanálisis freudiano clásico (que consideraba el amor filial una consecuencia secundaria de la pulsión oral de satisfacción del hambre) como al conductismo mecanicista de Watson (que reducía el afecto a un condicionamiento operante secundario ante el refuerzo alimenticio).

1. **Konrad Lorenz y la Impronta (*Troquelado*, 1935)**: Desde la etología comparada, Lorenz demostró que las crías de aves nidífugas (patos y gansos) siguen ciegamente al primer objeto móvil de gran tamaño que perciben tras la eclosión del huevo. Esta vinculación temprana, denominada **impronta**, tiene lugar durante un **período crítico o sensible** muy breve e irreversible, y no depende en absoluto del alimento, sino de una predisposición biológica innata orientada a mantener la proximidad con un adulto protector frente a los depredadores.
2. **Harry Harlow y el experimento con macacos Rhesus (1958)**: Harlow crió crías de macaco rhesus separadas de sus madres biológicas, ofreciéndoles dos madres sustitutas artificiales en sus jaulas: una "madre de alambre" que portaba un biberón con leche caliente, y una "madre de felpa suave" recubierta de tejido cálido que no suministraba alimento alguno. Los resultados fueron incontestables: los macacos pasaban entre 17 y 18 horas al día abrazados a la madre de felpa suave y sólo acudían a la madre de alambre el tiempo estrictamente indispensable para alimentarse (menos de una hora al día). Además, cuando se introducía en la jaula un artefacto amenazante mecánico que generaba terror, los monos huían desesperadamente a refugiarse y abrazar a la madre de felpa, obteniendo consuelo somático y atreviéndose posteriormente a explorar el objeto extraño. Harlow acuñó el concepto clave de **confort de contacto (*contact comfort*)**, demostrando científicamente que el afecto físico, la calidez táctil y la contención sensorial constituyen una necesidad biológica primaria tan indispensable como la nutrición.

```
                EL EXPERIMENTO DE HARRY HARLOW (1958)

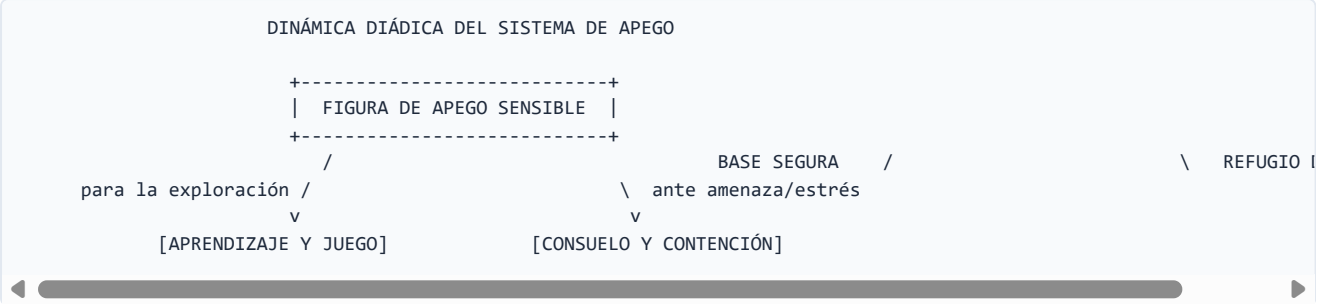
    [MADRE DE ALAMBRE CON BIBERÓN]      [MADRE DE FELPA SUAVE (SIN ALIMENTO)]
           (Solo nutrición)                    (Confort de contacto)
                  |                                   |
          Pasa < 1 hora/día                   Pasa 17-18 horas/día
                  |                                   |
     Hambre fisiológica satisfecha          Base segura y refugio de calma
                                            ante situaciones de terror
```

2.2. La Teoría del Apego de John Bowlby

El psiquiatra y psicoanalista británico **John Bowlby** (1907-1990), por encargo inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1951 para estudiar la salud mental de los niños sin hogar en la posguerra europea, y consolidado en su célebre trilogía *El apego y la pérdida* (1969, 1973, 1980), fusionó la etología evolutiva, el psicoanálisis relacional, la cibernética y la psicología cognitiva para formular la **Teoría del Apego**.

Bowlby definió el **apego** como un lazo afectivo duradero y profundo que una persona establece con otra figura específica (denominada **figura de apego** o cuidador principal), caracterizado por la tendencia innata a buscar y mantener la proximidad física hacia ella, especialmente en momentos de amenaza, fatiga, enfermedad o dolor, utilizándola como fuente de protección y seguridad.

El sistema de apego opera mediante dos funciones complementarias indispensables: * **Base segura (*secure base*)**: La presencia y disponibilidad emocional de la figura de apego permite al niño aventurarse a explorar el entorno físico y social circundante, sabiendo que, si surge un peligro, puede regresar rápidamente hacia ella. * **Refugio de seguridad y consuelo (*safe haven*)**: Espacio físico y relacional al que el infante retorna cuando experimenta miedo, alarma, malestar o dolor para recibir contención afectiva, alivio fisiológico y restablecimiento del equilibrio homeostático.



2.3. Los Modelos Operativos Internos (MOI)

Uno de los constructos teóricos más fecundos de Bowlby es el de los **Modelos Operativos Internos (MOI)** o *Internal Working Models* (IWM). A partir de la reiteración diaria de miles de interacciones con sus cuidadores primarios durante los primeros años de vida, el niño no almacena recuerdos aislados, sino que construye una representación cognitiva y afectiva interiorizada (un mapa mental o esquema relacional inconsciente) sobre cómo funciona el mundo interpersonal.

El MOI integra dos dimensiones dialécticas inseparables: 1. **Modelo del Yo (*Self-Model*)**: Representación cognitiva de la propia valía personal. Responde a la pregunta inconsciente: *"¿Soy una persona digna de ser amada, protegida y respetada?"*. Si el entorno ha sido sensible y amoroso, el niño construye un modelo de sí mismo de alta valía y autoeficacia. 2. **Modelo del Otro (*Other-Model*)**: Representación cognitiva sobre los demás. Responde a la pregunta: *"¿Son las otras personas accesibles, fiables, benevolentes y dignas de confianza cuando necesito ayuda?"*.

Estos modelos operativos internos muestran una alta estabilidad temporal y tienden a operar como profecías autocumplidas: un niño con un MOI negativo proyectará hostilidad o abandono sobre sus maestros, compañeros y, en la edad adulta, sobre su pareja e hijos, perpetuando la **transmisión intergeneracional de los patrones de apego**.

---

3. La Formación del Vínculo Afectivo

3.1. Fases Evolutivas del Apego según John Bowlby

La vinculación afectiva no surge de forma instantánea al nacer, sino que atraviesa un complejo proceso ontogenético de construcción a lo largo de los tres primeros años de vida. Bowlby dividió esta evolución en cuatro fases diferenciadas:

```
                FASES DE FORMACIÓN DEL APEGO (BOWLBY)
=========================================================================
1. FASE DE PREAPEGO (0 a 6-8 semanas):
   * Señales innatas indiscriminadas (llanto, sonrisa refleja, agarre).
   * Prefiere rostros y voces humanas pero no discrimina a una persona única.
   * No hay protesta ni angustia ante la separación de la madre.
-------------------------------------------------------------------------
2. FASE DE FORMACIÓN DEL APEGO (6-8 semanas a 6-8 meses):
   * Respuestas diferenciadas hacia las figuras de apego conocidas.
   * Sonríe y balbucea con mayor facilidad ante la madre.
   * Todavía no protesta ante la separación ni teme a personas extrañas.
-------------------------------------------------------------------------
3. FASE DE APEGO BIEN DEFINIDO O FOCALIZADO (6-8 meses a 24 meses):
   * El vínculo afectivo queda plenamente consolidado y focalizado.
   * Emerge el miedo o cautela ante extraños (angustia del 8º mes de Spitz).
   * Ansiedad o protesta aguda de separación cuando el cuidador se aleja.
   * Locomoción activa (gateo/marcha) para seguir y mantener proximidad.
-------------------------------------------------------------------------
4. FASE DE ASOCIACIÓN CON CORRECCIÓN DE OBJETIVOS (24-36 meses en adelante):
   * Comprensión de las metas, deseos y planes del progenitor (*partnership*).
   * Disminuye la necesidad de contacto físico continuo; tolera separaciones.
   * Negociación verbal de ausencias y retornos mediante el lenguaje.
=========================================================================
```

3.2. Evaluación Experimental y Tipologías del Apego Infantil: Mary Ainsworth

La psicóloga estadounidense-canadiense **Mary Salter Ainsworth** (1913-1999), colaboradora de Bowlby, introdujo la rigurosa comprobación empírica en la teoría del apego. En su célebre estudio en Baltimore (*Patterns of Attachment*, 1978), diseñó el procedimiento de laboratorio estandarizado denominado la **Situación Extraña (*Strange Situation Procedure - SSP*)**.

3.2.1. El Procedimiento de la Situación Extraña

Diseñado para bebés de entre **12 y 18 meses**, consta de **ocho episodios estructurados de tres minutos cada uno** (con una duración total de unos 20-25 minutos), diseñados para elevar progresivamente el estrés del lactante mediante la introducción de un adulto extraño y dos separaciones y reencuentros breves con la madre: 1. *Episodio 1*: Madre y bebé entran en la sala experimental con juguetes (30 segundos). 2. *Episodio 2*: La madre se sienta en silencio y el bebé explora la sala y los juguetes (evaluación de base segura). 3. *Episodio 3*: Entra un adulto extraño, conversa con la madre y se aproxima a jugar con el bebé (miedo a extraños). 4. *Episodio 4*: **Primera separación**: La madre sale discretamente de la sala, quedando el bebé solo con el extraño (ansiedad de separación). 5. *Episodio 5*: **Primer reencuentro**: La madre regresa, consuela al bebé y el extraño se retira (evaluación de la respuesta de reunión). 6. *Episodio 6*: **Segunda separación**: La madre vuelve a marcharse, dejando al bebé completamente solo en la sala (estrés máximo). 7. *Episodio 7*: El adulto extraño regresa a la sala e intenta calmar al bebé. 8. *Episodio 8*: **Segundo reencuentro**: La madre regresa, saluda y consuela al bebé; el extraño sale.

> *[!IMPORTANT] Para determinar el patrón de apego, el elemento diagnóstico más decisivo de la Situación Extraña* ***no es la reacción del bebé durante la separación, sino su conducta conductual y afectiva en los episodios de reencuentro (episodios 5 y 8)*** *con la figura de apego.*

3.2.2. Patrones de Apego de Ainsworth (Tipologías A, B y C)

A partir del análisis de las grabaciones de la Situación Extraña, Ainsworth identificó tres patrones organizados:

1. **Apego Seguro (Tipo B)** (Aproximadamente 60-65% de la población):
2. *Conducta*: Utiliza a la madre como base segura para explorar activamente los juguetes. Muestra malestar o llanto moderado durante las separaciones. En el reencuentro, **busca activamente el contacto físico, la mirada y el abrazo de la madre**, logrando calmarse con rapidez (1-2 minutos) y volviendo a reanudar el juego exploratorio.

3. *Estilo de cuidado parental*: Padres caracterizados por una alta **sensibilidad materna**, capacidad de sintonía afectiva, disponibilidad continua y respuestas contingentes y cálidas ante las señales del niño.
4. **Apego Inseguro-Evitativo (Tipo A)** (Aproximadamente 20% de la población):
5. *Conducta*: Apenas interactúa con la madre al explorar la sala. Cuando la madre se marcha, muestra escasa o nula protesta externa, pareciendo indiferente. En los reencuentros, **evita activamente la proximidad, retira la mirada, ignora a la madre o se enfoca obsesivamente en los juguetes**. Sin embargo, los registros de monitorización fisiológica demuestran que presentan una taquicardia severa y elevadísimos niveles de cortisol (estrés interno masivo), habiendo aprendido a inhibir la expresión del afecto para no ser rechazados.
6. *Estilo de cuidado parental*: Cuidadores rechazantes, impacientes, fríos, con escasa tolerancia al llanto o que rechazan activamente el contacto corporal estrecho.
7. **Apego Inseguro-Ambivalente o Resistente (Tipo C)** (Aproximadamente 10-15% de la población):
8. *Conducta*: Pasan la mayor parte del tiempo pegados a la madre, con exploración prácticamente nula de los juguetes. Durante la separación exhiben una angustia masiva e incontrolable. En los reencuentros manifiestan una **ambivalencia desesperada: buscan con vehemencia el contacto físico, pero inmediatamente empujan, patean o agreden a la madre**, resultando inconsolables durante largo rato.
9. *Estilo de cuidado parental*: Cuidadores impredecibles, inconstantes e intermitentes (a veces excesivamente cariñosos e invasivos, y otras veces negligentes o ausentes), generando en el niño una estrategia de hiperactivación de las demandas de apego.

3.3. El Descubrimiento del Apego Desorganizado: Mary Main y Judith Solomon

En la década de 1980, los investigadores comprobaron que un porcentaje significativo de niños procedentes de familias de alto riesgo psicosocial, pobreza extrema o con antecedentes de maltrato no encajaba en ninguna de las tres categorías de Ainsworth. En 1986, **Mary Main y Judith Solomon** identificaron y categorizaron un cuarto patrón:

1. **Apego Inseguro-Desorganizado/Desorientado (Tipo D)** (Presente en menos del 5% de la población normal, pero en más del **70-80% de niños víctimas de maltrato o negligencia grave**):
2. *Conducta*: Caracterizado por el **colapso total de cualquier estrategia organizada de adaptación**. En el reencuentro con la figura de apego, el bebé exhibe conductas simultáneas y paradójicas: aproximarse a la madre pero caminando hacia atrás o con la mirada desviada hacia el techo; quedarse completamente inmóvil o paralizado en posturas corporales congeladas (**freezing** o inmovilidad tónica); posturas asimétricas; balanceos estereotipados; o pasar en un segundo de la búsqueda desesperada de apego al terror visible.
3. *Mecanismo psicológico subyacente*: Main lo definió como la trampa biológica del **"miedo sin solución" (*fright without solution*)**. En el apego normal, cuando el niño siente miedo huye hacia su cuidador; pero en el apego desorganizado, **la figura de apego es simultáneamente la fuente del terror y el único refugio biológico de consuelo**. El circuito neuronal del infante colapsa entre el impulso de aproximación y el de huida.
4. *Estilo de cuidado parental*: Progenitores que generan miedo, que maltratan físicamente, abusan sexualmente, sufren adicciones severas o arrastran **traumas y pérdidas no elaboradas** en su propia infancia que los convierten en figuras atemorizantes o atemorizadas (*frightening or frightened caregivers*).

```
                SISTEMATIZACIÓN DE LOS PATRONES DE APEGO
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO   | DENOMINACIÓN      | CONDUCTA REUNIÓN   | PAUTA PARENTAL         |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO B | Seguro            | Busca consuelo y   | Sensibilidad, calidez  |
|        |                   | reanuda juego.     | y disponibilidad.      |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO A | Inseguro-         | Evita mirada y     | Rechazo del contacto,  |
|        | Evitativo         | contacto físico.   | frialdad e impaciencia.|
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO C | Inseguro-         | Búsqueda y agresión| Inconsistencia e       |
|        | Ambivalente       | simultánea.        | imprevisibilidad.      |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO D | Inseguro-         | Colapso, freezing, | Violencia, negligencia,|
|        | Desorganizado     | miedo visible.     | trauma no resuelto.    |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
```

3.4. Continuidad del Apego en el Ciclo Vital: La Entrevista de Apego para Adultos (AAI)

Mary Main, Nancy Kaplan y Jude Cassidy (1985) desarrollaron la **Entrevista de Apego para Adultos (*Adult Attachment Interview - AAI*)**, demostrando que los patrones de apego infantil se transforman en representaciones narrativas y estilos vinculares estables en la vida adulta: 1. **Adulto Autónomo / Seguro**: Habla de su infancia con coherencia, fluidez y objetividad, integrando experiencias positivas y negativas sin defensas distorsionadas. 2. **Adulto Desentendido / Evitativo (*Dismissing*)**: Minimiza la importancia de los vínculos afectivos ("mi infancia no tuvo ninguna importancia", "nunca necesité a mis padres"), ofrece recuerdos idealizados pero vacíos de anécdotas concretas o niega el dolor. 3. **Adulto Preocupado / Enredado (*Preoccupied*)**: Permanece atrapado en quejas interminables, reproches coléricos o confusión discursiva sobre sus progenitores. 4. **Adulto Irresuelto / Desorganizado (*Unresolved*)**: Exhibe lapsos graves en la monitorización del razonamiento y el discurso cuando habla de pérdidas, abusos o traumas del pasado (silencios prolongados, asociaciones ilógicas), correlacionando masivamente con la crianza de hijos con apego desorganizado (transmisión intergeneracional).

---

4. Problemas Específicos de una Inadecuada Configuración del Apego

4.1. Privación Afectiva Temprana, Depresión Anaclítica y Hospitalismo

Las investigaciones pioneras sobre privación afectiva institucional sentaron las bases para denunciar el impacto devastador de la carencia vincular en la primera infancia:

- **René Spitz y el Hospitalismo (1945, 1946)**: Spitz investigó comparativamente dos grupos de lactantes: hijos de madres reclusas que cuidaban a sus bebés en guarderías penitenciarias frente a bebés abandonados en hospicios u orfanatos asépticos donde las enfermeras cubrían exclusivamente sus necesidades de nutrición e higiene física, sin tiempo para el afecto individualizado. Spitz documentó dos graves cuadros patológicos:
- **Depresión anaclítica**: Sobreviene cuando un bebé que disfrutó de un vínculo afectivo inicial normal durante sus primeros 6 meses es separado bruscamente de su madre. Atraviesa tres fases: fase de protesta (llanto continuo y agitación motriz), fase de desesperanza/retraimiento (rechazo al alimento, pérdida de peso, mutismo y apatía con mirada vidriosa) y fase de desapego o recuperación parcial si regresa la figura materna antes de los 3-5 meses.
- **Síndrome de hospitalismo**: Si la privación afectiva total supera los cinco o seis meses ininterrumpidos en instituciones frías, el deterioro biopsicosocial se vuelve **irreversible**. Los bebés caen en un marasmo letárgico, detención del crecimiento somático (**enanismo psicógeno** por inhibición de la hormona del crecimiento), supresión del sistema inmunitario, balanceos autoagresivos, pérdida de la locomoción y del

habla, culminando en elevadísimas tasas de mortalidad infantil pese a una alimentación biológicamente perfecta.

- **Informe Bowlby para la OMS (1951)**: Bajo el título *Maternal Care and Mental Health*, John Bowlby concluyó de forma categórica que *"un lactante y un niño pequeño deben experimentar una relación cálida, íntima y continuada con su madre (o sustituto materno permanente) en la que ambos encuentren satisfacción y goce"*, desaconsejando radicalmente el internamiento de menores de 3 años en instituciones asistenciales cerradas y sentando las bases mundiales del **acogimiento familiar prioritario**.

4.2. Trastornos del Apego en las Clasificaciones Psiquiátricas (DSM-5 y CIE-11)

Las clasificaciones diagnósticas internacionales (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, **DSM-5** de la APA, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, **CIE-11** de la OMS) delimitan con suma precisión dos trastornos clínicos del apego infantojuvenil provocados por un patrón extremo de cuidado insuficiente (negligencia social grave, cambios continuos de cuidadores principales o crianza en orfanatos masificados):

```
                TRASTORNOS DEL APEGO (DSM-5 / CIE-11)
=========================================================================
TRASTORNO DE APEGO REACTIVO (TAR / RAD):
* Patrón constante de conducta emocionalmente inhibida y retraída hacia los
  cuidadores adultos de referencia.
* El menor rara vez o casi nunca busca consuelo cuando siente malestar.
* Rara vez o casi nunca responde al consuelo cuando se le ofrece.
* Alteración social y emocional persistente: respuesta social mínima hacia
  los demás, afecto positivo limitado y episodios inexplicables de irritabilidad,
  tristeza o miedo no provocado en interacciones cotidianas no amenazantes.
-------------------------------------------------------------------------
TRASTORNO DE RELACIÓN SOCIAL DESINHIBIDA (TRSD / DSED):
* Patrón constante en el que el menor se aproxima e interactúa activamente
  con adultos extraños de manera indiscriminada.
* Ausencia o franca reducción de la reticencia o cautela para aproximarse a
  personas desconocidas.
* Excesiva familiaridad verbal o física (abrazar a desconocidos, subirse a
  su regazo), vulnerando los límites sociales normativos de la cultura.
* Disminución o ausencia total de la comprobación del paradero del cuidador
  principal cuando se aleja en entornos desconocidos (parques, calles).
* Disposición inmediata a marcharse con un adulto extraño sin ninguna vacilación.
=========================================================================
```

> *[!CAUTION] En exámenes de oposición es crítico recordar que el **TAR** se caracteriza por la **inhibición y el retraimiento afectivo**, mientras que el **TRSD** se define por la **desinhibición social indiscriminada**. Ambos exigen como criterio etiológico haber sufrido **negligencia grave o privación afectiva temprana** antes de los 5 años de edad.*

4.3. Trauma Relacional Temprano y Neurobiología del Estrés Tóxico

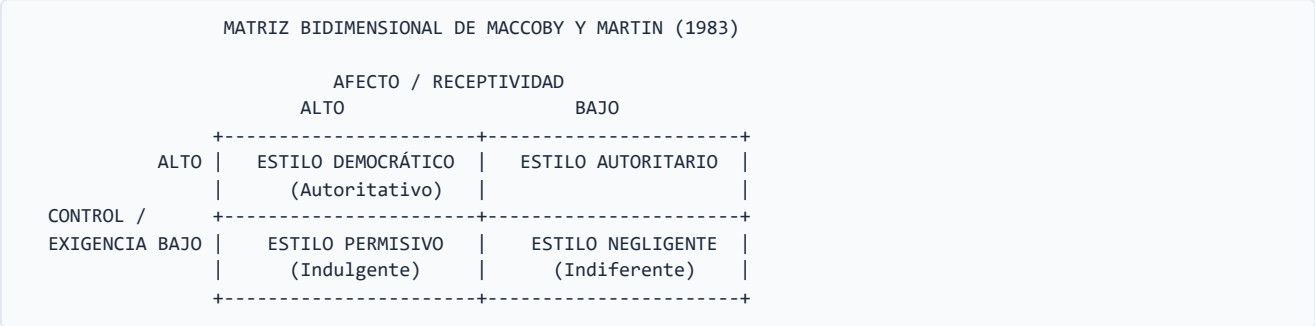
El apego desorganizado y el maltrato intrafamiliar crónico no sólo moldean la psicología del menor, sino que alteran profundamente la arquitectura del cerebro en desarrollo (Bruce Perry, 2006; Bessel van der Kolk, 2014): 1. **Hiperactivación crónica del eje HHA**: La constante amenaza parental somete al sistema a una elevación tóxica de **cortisol** y adrenalina. Este estrés tóxico genera neurotoxicidad en el **hipocampo** (atrofia neuronal con afectación de la memoria y el aprendizaje) e hipertrofia reactiva de la **amígdala** (hipervigilancia permanente, interpretando rostros neutros como amenazantes). 2. **Desconexión prefrontal y desregulación afectiva**: La corteza prefrontal ventromedial y el cuerpo calloso ven ralentizado su desarrollo, reduciendo drásticamente la capacidad de autorregulación emocional, tolerancia a la frustración y control de los impulsos agresivos. 3. **Disociación estructural**: Mecanismo de defensa psicobiológico donde el menor "apaga" su conciencia o desconecta las emociones de sus sensaciones corporales para soportar el dolor del abuso, manifestándose posteriormente en la adolescencia mediante alexitimia, adicciones, autolesiones y trastornos disociativos.

5. Modelos Educativos Parentales y Consecuencias en los Menores

5.1. El Modelo Tipológico de Diana Baumrind y su Reformulación Bidimensional

El análisis de la socialización familiar se estructuró a partir de las investigaciones clásicas de **Diana Baumrind** (1966, 1971), quien observó las interacciones paterno-filiales e identificó tres estilos básicos: autoritario, permisivo y autoritativo (democrático). Posteriormente, **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)** perfeccionaron el modelo, articulándolo sobre una matriz bidimensional basada en el cruce de dos dimensiones ortogonales independientes:

1. **Exigencia / Control / Demandas parentales (*Demandingness*)**: Grado en que los progenitores establecen normas, límites claros, supervisión, exigencias de madurez y disciplina congruente sobre la conducta de los hijos.
2. **Afecto / Receptividad / Apoyo parental (*Responsiveness*)**: Grado en que los padres muestran sensibilidad, calidez afectiva, apoyo emocional, comunicación bidireccional y disponibilidad para satisfacer las necesidades individuales de sus hijos.



5.2. Caracterización Pormenorizada de los Cuatro Estilos Educativos

5.2.1. Estilo Democrático o Autoritativo (+ Control, + Afecto)

- **Pautas parentales**: Los progenitores combinan altos niveles de calidez afectiva y diálogo con un control normativo firme, coherente y predecible. Las normas familiares no se imponen arbitrariamente, sino que se explican y razonan en función de la edad del menor (**disciplina inductiva**). Fomentan la expresión de opiniones, escuchan de forma activa, estimulan la autonomía y aplican consecuencias lógicas o reparatorias ante las faltas, sin recurrir jamás a la agresión física o la degradación psicológica.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- Elevada autoestima y autoconcepto ajustado.
- Locus de control interno y sólida autorregulación emocional.
- Gran competencia social, empatía y habilidades asertivas de resolución de conflictos.
- Alto rendimiento académico y perseverancia ante las tareas.
- Predominio indiscutible de patrones de apego seguro.

5.2.2. Estilo Autoritario (+ Control, - Afecto)

- **Pautas parentales**: Se caracteriza por la imposición vertical, rígida y unilateral de normas indiscutibles, sustentadas en el axioma del "porque yo lo mando". Los niveles de afecto, elogio y comunicación bidireccional son mínimos o inexistentes. Los progenitores exigen obediencia ciega y recurren sistemáticamente a métodos de disciplina punitiva, coactiva, castigo corporal, aislamiento y humillación verbal para doblegar la voluntad del niño.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:

- Baja autoestima y sentimientos crónicos de incompetencia o culpa.
- Locus de control externo: actúan bien únicamente por miedo a la sanción externa, no por convicción moral interiorizada.
- Dependencia de la autoridad, sumisión pasiva ante figuras de poder o, alternativamente, **rebeldía agresiva reactiva** y conductas antisociales encubiertas fuera del hogar.
- Escasa competencia social, timidez y predisposición a trastornos ansioso-depresivos.

5.2.3. Estilo Permisivo o Indulgente (- Control, + Afecto)

- **Pautas parentales**: Progenitores excesivamente afectuosos, comunicativos y complacientes, pero totalmente incapaces de fijar límites, estructurar rutinas o exigir responsabilidades y pautas de madurez acordes a la edad. Evitan a toda costa el conflicto o la frustración del niño, adoptando un rol de "amigos" o subordinados a los caprichos del menor. Rara vez aplican castigos y ceden inmediatamente ante las rabietas.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- **Bajísimo nivel de tolerancia a la frustración** y descontrol de impulsos.
- Egocentrismo exacerbado, actitudes demandantes y tiránicas hacia la familia (**síndrome del emperador** o génesis de la violencia filioparental).
- Escaso rendimiento escolar por falta de disciplina y hábitos de estudio.
- Alta vulnerabilidad a caer en adicciones conductuales o de sustancias al llegar a la adolescencia.

5.2.4. Estilo Negligente o Indiferente (- Control, - Afecto)

- **Pautas parentales**: Es el estilo más dañino y destructivo para el desarrollo infantil. Se caracteriza por la ausencia casi total tanto de afecto y receptividad como de supervisión y límites normativos. Los progenitores están absorbidos por sus propios problemas (adicciones, patología psiquiátrica, marginalidad o indiferencia culpable) e invierten el mínimo tiempo y esfuerzo posible en la crianza. Se desentienden de las necesidades físicas, higiénicas, escolares y afectivas del menor (**negligencia infantil**).
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- Graves carencias en todas las áreas del desarrollo (retrasos en lenguaje, motricidad y cognición).
- Autoconcepto profundamente deteriorado e indefensión aprendida.
- Elevadísima correlación con **fracaso escolar masivo y absentismo crónico**.
- Aparición temprana de trastornos de conducta graves, delincuencia juvenil, conductas disociales e inicio precoz en el consumo de drogas.
- Alta prevalencia de apegos desorganizados y trastornos del apego (TAR/TRSD).

Estilo Educativo	Afecto y Receptividad	Control y Exigencia	Consecuencias Principales en los Menores
Democrático	**Alto**	**Alto**	Alta autoestima, autonomía, competencia social, apego seguro, éxito escolar.
Autoritario	**Bajo**	**Alto**	Baja autoestima, sumisión o rebeldía, ansiedad, locus de control externo.
Permisivo	**Alto**	**Bajo**	Baja tolerancia a frustración, tiranía (síndrome del emperador), impulsividad.
Negligente	**Bajo**	**Bajo**	Graves desajustes disociales, fracaso escolar, desapego, vulnerabilidad a adicciones.

6. La Parentalidad Positiva

6.1. Marco Doctrinal y Político: La Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa

El concepto contemporáneo de **parentalidad positiva** supuso una superación definitiva del modelo paternalista y jerárquico tradicional de la patria potestad centrado en los derechos de los progenitores, sustituyéndolo por un modelo de responsabilidad parental fundamentado en los derechos del niño consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989).

El texto de referencia a escala continental es la **Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad**, adoptada el 13 de diciembre de 2006. En ella se define oficialmente la parentalidad positiva como:

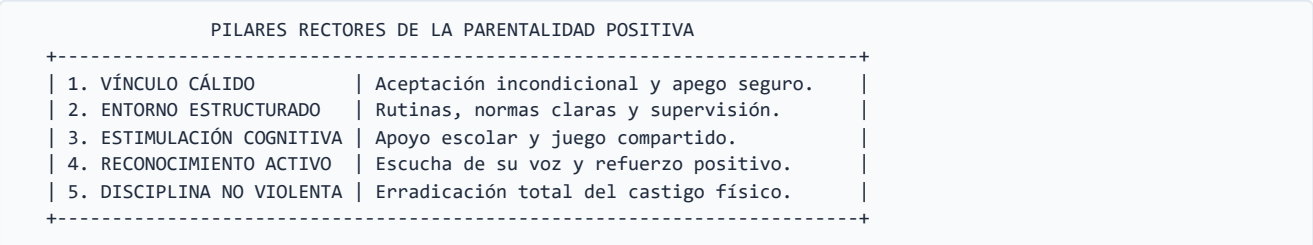
> *"El comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño."*

La Recomendación subraya de forma tajante que los poderes públicos deben abandonar la postura reactiva que interviene únicamente cuando el daño se ha consumado, asumiendo un rol proactivo de **apoyo universal y capacitación a las familias** para que puedan ejercer adecuadamente sus responsabilidades parentales.

6.2. Principios Rectores de la Parentalidad Positiva

El Ministerio de Sanidad y Política Social, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y expertos de referencia (Rodrigo et al., 2010), desglosan los principios indispensables que estructuran el ejercicio de la parentalidad positiva:

1. **Vínculos afectivos cálidos**: Demostración explícita y cotidiana de afecto, ternura, aceptación incondicional y disponibilidad física y psicológica para que el niño se sienta querido, seguro y protegido.
2. **Entorno estructurado y coherente**: Suministro de pautas, horarios, rutinas y normas claras y predecibles que actúen como organizadores de la vida diaria, proporcionando al niño un marco de seguridad física y mental.
3. **Estimulación y apoyo al aprendizaje**: Promoción del desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y socioemocional del menor, mostrando interés por su vida escolar y facilitando oportunidades de juego, cultura y socialización.
4. **Reconocimiento y validación del menor**: Escucha activa, valoración de sus opiniones en los asuntos familiares que le afecten según su madurez, y reconocimiento de sus progresos y logros personales.
5. **Capacitación y educación no violenta (*Erradicación total del castigo corporal*)**: Establecimiento de límites firmes pero fundamentados en la **disciplina inductiva y no punitiva**. El Consejo de Europa y la legislación española prohíben de forma absoluta el castigo corporal ("la bofetada a tiempo"), las amenazas, los insultos o la humillación, por ser violaciones intolerables de la dignidad del menor que modelan la agresión como vía de resolución de conflictos.



6.3. Marco Normativo de Protección: LOPIVI y Legislación Andaluza

La consagración legal obligatoria de la parentalidad positiva en España y Andalucía se articula a través de disposiciones de máximo rango: * **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)**: - En su articulado (especialmente arts. 3 y 25), mandata a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) la obligación de promover programas formativos y servicios comunitarios de apoyo a la parentalidad positiva. - Define legalmente el **buen trato infantil** como aquel que garantiza el respeto pleno a los derechos fundamentales de los niños, su desarrollo integral y una vida libre de cualquier manifestación de violencia. * **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: - Dedica capítulos específicos a la promoción de la parentalidad positiva y la prevención de la desprotección infantil en el ámbito municipal. - Impone a los Servicios Sociales Comunitarios la realización de actuaciones socioeducativas grupales y familiares que refuercen las capacidades parentales de las familias andaluzas.

---

7. La Intervención del Educador/a Social en los Servicios Sociales Municipales de Utrera

En el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el Educador y la Educadora Social actúan como agentes de cambio técnico en la promoción de vínculos seguros y modelos educativos funcionales, insertos en el equipo básico multidisciplinar de los Servicios Sociales Comunitarios (art. 29 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía).

```
        CIRCUITO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA FAMILIAR EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y VALORACIÓN   | Visitas a domicilio, cribado en CSSC
                            | y aplicación del Instrumento VALÓRAME.
-------------------------------------------------------------------------
2. INTERVENCIÓN DIRECTA     | Elaboración y seguimiento del PEI
                            | en el domicilio: rutinas, apego y afecto.
-------------------------------------------------------------------------
3. CAPACITACIÓN GRUPAL      | Escuelas de Familias y talleres de
                            | parentalidad positiva en CSSC Utrera.
-------------------------------------------------------------------------
4. TRABAJO EN RED LOCAL     | Coordinación con ETF (Decreto 100/2022),
                            | CAIT, EMAE (Absentismo) y ERACIS+.
=========================================================================
```

7.1. Valoración Técnica y Detección de Desajustes en el Domicilio

- **Observación natural en el domicilio**: El Educador Social accede al contexto de convivencia familiar en Utrera (analizando cómo se comunican progenitores e hijos, si existe contacto visual cálido o por el contrario hostilidad, gritos o negligencia higiénica).
- **Aplicación del Instrumento VALÓRAME (Orden de 30 de julio de 2019)**: Evalúa la gravedad de la desprotección infantil, identificando tipologías de maltrato emocional, negligencia física o estilos negligentes/autoritarios que colocan al menor en situación de riesgo social.

7.2. Intervención Especializada con Familias en Riesgo: Coordinación con ETF

- En los casos de riesgo moderado o grave, el Educador Social de Servicios Sociales Comunitarios coordina o se integra en los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, regulados por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**.
- Diseña el **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)** como concreción del Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 34 Ley 9/2016), trabajando en el propio hogar familiar técnicas de modelado de conducta, resolución de conflictos sin violencia, refuerzo positivo y reorganización de rutinas diarias.

7.3. Escuelas de Familias y Abordaje del Absentismo y la Vulnerabilidad

- **Escuelas de Familias y Grupos Socioeducativos**: Impartidos en la sede municipal de los Servicios Sociales de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), capacitando a madres y padres en habilidades de comunicación asertiva, gestión de rabietas, uso responsable de pantallas y establecimiento de límites no punitivos.
- **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Desactivación de estilos parentales negligentes o excesivamente permisivos que toleran que el menor falte a clase en los colegios e institutos de Utrera (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**), vinculando el absentismo a la falta de supervisión y desestructuración familiar.
- **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías**: En el marco de la estrategia **ERACIS+**, despliegue de talleres comunitarios de crianza positiva en la **Barriada El Tinte** y en las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), acercando los recursos de apoyo psicosocial a las familias con mayores índices de vulnerabilidad social.

---

8. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de apego (John Bowlby)**: Lazo afectivo profundo y duradero hacia una figura específica que proporciona seguridad y protección, motivando la búsqueda de proximidad.
2. **Funciones del sistema de apego**: Operar como **base segura** para la exploración física/social y como **refugio de seguridad y consuelo** ante el estrés o la alarma.
3. **Modelos Operativos Internos (MOI / IWM)**: Esquemas cognitivos internos interiorizados en la infancia que integran el modelo del Yo (valía propia) y el modelo del Otro (confianza en los demás).
4. **Impronta (Troquelado)**: Fenómeno etológico de apego innato descubierto por Konrad Lorenz en aves nidífugas durante un período crítico, independiente de la nutrición.
5. **Confort de contacto (*Contact comfort*)**: Hallazgo experimental de Harry Harlow (1958) con macacos rhesus; la necesidad de afecto y contacto cálido es una pulsión biológica primaria independiente del alimento.
6. **Cuatro fases del apego de Bowlby**: 1) Preapego (0-2 meses); 2) Formación del apego (2-7 meses); 3) Apego bien definido (7-24 meses); 4) Asociación con corrección de objetivos (24-36 meses en adelante).
7. **La Situación Extraña (1978)**: Procedimiento experimental estandarizado de laboratorio de 8 episodios diseñado por Mary Ainsworth para clasificar patrones de apego en lactantes de 12-18 meses.
8. **Momento diagnóstico clave de la Situación Extraña**: La conducta y respuesta del bebé durante los **episodios de reencuentro** (episodios 5 y 8) con la figura de apego.
9. **Apego Seguro (Tipo B)**: 60-65% de la población; utiliza al cuidador como base segura, llora moderadamente en la separación y se calma con rapidez buscando contacto en el reencuentro.
10. **Apego Inseguro-Evitativo (Tipo A)**: 20%; aparente indiferencia en la marcha e inhibición/evitación deliberada del contacto en el reencuentro, con estrés fisiológico encubierto muy elevado.
11. **Apego Inseguro-Ambivalente/Resistente (Tipo C)**: 10-15%; angustia masiva en la separación y conducta paradójica en la reunión (busca contacto y muestra cólera/agresión al mismo tiempo).
12. **Apego Inseguro-Desorganizado/Desorientado (Tipo D)**: Descubierto por Mary Main y Judith Solomon (1986); colapso de estrategias defensivas, congelación (*freezing*) y conductas anómalas; prevalencia masiva en maltrato infantil.

13. **Entrevista de Apego para Adultos (AAI)**: Creada por Mary Main y colaboradores (1985); clasifica los apegos adultos en Autónomo, Desentendido (*Dismissing*), Preocupado (*Preoccupied*) e Irresuelto/Desorganizado.
14. **Hospitalismo y depresión anaclítica**: Términos acuñados por René Spitz (1945, 1946) para documentar el letargo, marasmo somático, atrofia del desarrollo y muerte por privación afectiva institucional prolongada.
15. **Informe Bowlby para la OMS (1951)**: Declaró indispensable el cuidado materno cálido continuo para la salud mental infantil, impulsando la erradicación del internamiento de lactantes en asilos.
16. **Trastorno de Apego Reactivo (TAR / RAD)**: Cuadro clínico (DSM-5 / CIE-11) caracterizado por inhibición afectiva, apatía social y ausencia de búsqueda de consuelo ante negligencia grave temprana.
17. **Trastorno de Relación Social Desinhibida (TRSD / DSED)**: Cuadro clínico caracterizado por sociabilidad indiscriminada, contacto íntimo con adultos desconocidos y ausencia de recelo social.
18. **Estrés tóxico en el neurodesarrollo**: Afectación del eje HHA que provoca atrofia del hipocampo por hipercortisolemia e hipertrofia de la amígdala con hipervigilancia crónica.
19. **Dimensiones de Maccoby y Martin (1983)**: Exigencia/Control (*Demandingness*) y Afecto/Receptividad (*Responsiveness*).
20. **Estilo Democrático o Autoritativo**: Alto afecto y alto control inductivo; produce alta autoestima, autonomía y éxito escolar.
21. **Estilo Autoritario**: Bajo afecto y alto control punitivo; genera sumisión, baja autoestima o agresividad reactiva encubierta.
22. **Estilo Permisivo o Indulgente**: Alto afecto y bajo control; fomenta baja tolerancia a la frustración, tiranía familiar y síndrome del emperador.
23. **Estilo Negligente o Indiferente**: Bajo afecto y bajo control; máximo factor de riesgo de conductas disociales y absentismo escolar crónico.
24. **Definición de Parentalidad Positiva**: Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa; conducta de los padres basada en el interés superior del menor, afecto, límites no violentos y apoyo pleno a sus capacidades.
25. **Prohibición del castigo corporal**: Consagrada en el ordenamiento español (modificación del Código Civil y LOPIVI 8/2021), erradicando el castigo físico como método disciplinario.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                        TEORÍA DEL APEGO Y VÍNCULO
========================================================================
* ANTECEDENTES : Lorenz (Impronta en aves) | Harlow (Confort de felpa).
* AUTOR TEORÍA : John Bowlby (Trilogía 1969-1980) | MOI (Modelos Operativos).
* FASES BOWLBY : Preapego (0-2m) -> Formación (2-7m) -> Apego definido (7-24m)
                 -> Asociación con corrección de objetivos (24-36m+).
* SITUACIÓN EXTRAÑA (Mary Ainsworth, 1978):
  - Seguro (Tipo B)     : Base segura, explora, consuelo rápido en reunión.
  - Evitativo (Tipo A)  : Aparente calma, evita contacto en reunión (estrés oculto).
  - Ambivalente (Tipo C): Angustia masiva, busca contacto y agrede a la vez.
* APEGO DESORGANIZADO (Main y Solomon, 1986 - Tipo D):
  - Colapso de estrategia, freezing, "miedo sin solución"; maltrato infantil.
------------------------------------------------------------------------
                   PSICOPATOLOGÍA DEL APEGO (DSM-5)
------------------------------------------------------------------------
* Trastorno Apego Reactivo (TAR)      : Inhibición, no busca ni acepta consuelo.
* Trastorno Relación Desinhibida (TRSD): Sociabilidad promiscua con extraños.
* René Spitz                          : Depresión anaclítica y Hospitalismo.
========================================================================
                   MODELOS EDUCATIVOS PARENTALES
========================================================================
* MACCOBY Y MARTIN (1983) a partir de BAUMRIND:
  - Democrático (+ Afecto, + Control) : Autoestima, empatía, apego seguro.
  - Autoritario (- Afecto, + Control) : Culpa, sumisión, agresividad reactiva.
  - Permisivo   (+ Afecto, - Control) : Descontrol, baja tolerancia frustración.
  - Negligente  (- Afecto, - Control) : Abandono, fracaso escolar, disocial.
------------------------------------------------------------------------
                       PARENTALIDAD POSITIVA
------------------------------------------------------------------------
* Consejo de Europa (Rec 2006/19) | LOPIVI (Ley 8/2021) | Ley 4/2021 Andalucía.
* Principios: Vínculo cálido, estructura, estimulación, escucha, NO violencia.
* Utrera: CSSC (Catalina de Perea), ETF (Decreto 100/2022), EMAE, ERACIS+.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Clave Desarticuladas)

1. **Atribuir la Situación Extraña a John Bowlby**:
   Trampa: Marcar a Bowlby como creador de la Situación Extraña.
   Realidad: Bowlby sentó las bases teóricas generales del apego; el diseño experimental de la Situación Extraña y la categorización original de los patrones A, B y C corresponde a **Mary Ainsworth** (1978).
2. **El origen del Apego Desorganizado**:
   Trampa: Afirmar que Ainsworth descubrió los cuatro tipos de apego.
   Realidad: Ainsworth descubrió y describió únicamente tres patrones (A, B y C). El cuarto patrón (Tipo D: Desorganizado/Desorientado) fue identificado por **Mary Main y Judith Solomon** en 1986.
3. **El criterio de valoración en la Situación Extraña**:
   Trampa: Considerar que el tipo de apego se determina evaluando el llanto del bebé durante la separación.
   Realidad: La separación genera estrés en casi todos los bebés; el criterio discriminante decisivo es **la conducta del infante durante los reencuentros (episodios 5 y 8)** con la madre.
4. **Diferencia clínica entre TAR y TRSD**:
   Trampa: Confundir el Trastorno de Apego Reactivo con el Trastorno de Relación Social Desinhibida.
   Realidad: El **TAR** es **inhibido, retraído e insensible al consuelo**; el **TRSD** es **socialmente desinhibido, confiado y familiar con personas totalmente desconocidas**. Ambos derivan de negligencia o institucionalización temprana.
5. **Autores del modelo bidimensional de estilos educativos**:
   Trampa: Atribuir a Diana Baumrind la matriz de cuatro estilos basada en las dos dimensiones (afecto y control).

Realidad: Baumrind definió originalmente tres estilos (democrático, autoritario y permisivo). Fueron **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)** quienes formalizaron la matriz bidimensional e introdujeron formalmente el cuarto estilo: el **estilo negligente o indiferente**.

6. **Alimentación como causa del apego**:
   Trampa: Afirmar que el apego del bebé hacia la madre surge como consecuencia directa de la alimentación láctea.
   Realidad: Los experimentos de Harry Harlow con macacos demostraron concluyentemente que el **confort de contacto** táctil y afectivo es la necesidad biológica primaria que funda el apego, no la nutrición.
7. **El "derecho a corregir moderadamente" en la patria potestad**:
   Trampa: Creer que en el ordenamiento jurídico español los padres conservan la facultad de aplicar un castigo físico moderado a sus hijos para disciplinarlos.
   Realidad: La Ley 54/2007 suprimió expresamente del Código Civil la facultad de "corregir moderadamente", y la **LOPIVI 8/2021** prohíbe taxativamente cualquier manifestación de castigo corporal o violencia física en el ámbito familiar.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La operatividad del Tema 32 en la práctica profesional del Educador/a Social de Utrera se refleja en los siguientes ejes asistenciales y preventivos:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Evaluación y cribado socioeducativo**: Detección de dinámicas de apego desorganizado o negligencia parental severa en entrevistas diagnósticas y visitas domiciliarias a familias perceptoras de ayudas de emergencia social o IMV.
3. **Aplicación preceptiva del Instrumento VALÓRAME**: Tipificación objetiva de la gravedad del desamparo o riesgo infantil (Orden de 30 de julio de 2019 de la Junta de Andalucía).
4. **Talleres de Crianza Positiva y Escuelas de Familias**: Espacios socioeducativos grupales dirigidos a progenitores con escasas habilidades de manejo conductual, erradicando el castigo físico y enseñando la técnica de la disciplina inductiva y límites predecibles.
5. **Coordinación con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**:
6. Derivación y cotrabajo interdisciplinar bajo el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, ejecutando en el propio domicilio familiar programas intensivos de capacitación parental orientados a preservar la permanencia del menor en su hogar y reparar los vínculos afectivos dañados.
7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Coordinación técnica con colegios e institutos (**CEIP Álvarez Quintero, CEIP Rodrigo Caro, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**).
9. Intervención directa ante estilos parentales permisivos o negligentes que toleran la desescolarización, estableciendo contratos socioeducativos de corresponsabilidad parental.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías Utreranas**:
11. Despliegue de actuaciones socioeducativas de dinamización familiar en el marco del Plan Local de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)** en la **Barriada El Tinte**.
12. Extensión descentralizada de programas de parentalidad positiva a los núcleos de población rurales y pedanías de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), combatiendo el aislamiento geográfico y dotando a las familias rurales de pautas de crianza respetuosa.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S.** (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum.
- **Baumrind, D.** (1971). Current patterns of parental authority. *Developmental Psychology*, 4(1p2), 1-103.
- **Bowlby, J.** (1951). *Maternal care and mental health*. World Health Organization Monograph Series, No. 2.
- **Bowlby, J.** (1969/1982). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Harlow, H. F.** (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13(12), 673-685.
- **Lorenz, K.** (1935). Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. *Journal für Ornithologie*, 83(2), 137-213.
- **Maccoby, E. E., & Martin, J. A.** (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). Wiley.
- **Main, M., & Solomon, J.** (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), *Affective development in infancy* (pp. 95-124). Ablex.
- **Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., & Martín, J. C.** (2010). *Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias*. FEMP.
- **Spitz, R. A.** (1945). Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 1(1), 53-74.
- **Consejo de Europa**. (2006). *Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección. *BOJA nº 111, de 13/06/2022*.
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba el instrumento VALÓRAME. *BOJA nº 150, de 06/08/2019*.